

TEMA 5.7 • OFTALMOLOGÍA

ojo rojo profundo 2

PERFIL EUNACOM 6.02.1.021

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Ojo Rojo Profundo: Patología de Córnea

El **ojo rojo profundo** (o periquerático) se define clínicamente cuando la inyección de los vasos sanguíneos llega e impacta directamente en el borde mismo de la córnea. Su causa más insidiosa y frecuente es la afectación de la córnea en sí misma, principalmente las **Queratitis** y las **Erosiones Corneales**.

Patrón Clínico Compartido: Síndrome Corneal

Cualquier daño o lesión al epitelio o estroma corneal generará un cuadro sintomatológico sumamente florido y ruidoso, caracterizado por: - **Ojo Rojo Profundo**. - Ardor sumamente **intenso**. - **Sensación de cuerpo extraño** muy dolorosa y punzante. - **Fotofobia**: el ardor y dolor empeoran dramáticamente al abrir el ojo hacia la luz. -

Blefaroespasmos: cierre tónico reflejo de los párpados. - **Epífora** (lagrimeo constante).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Clave de la Pupila en Patología Corneal: En las queratitis y erosiones puras, la **pupila suele estar completamente normal**. Se descarta así rápidamente una Uveítis (que tendría miosis) y un Glaucoma Agudo (que tendría midriasis fija).

1. Queratitis

Es la inflamación y ulceración franca de la capa superficial de la córnea debido a procesos agresivos o infecciosos.

- **Etiologías Principales:**
- - **Queratitis Bacteriana:** Característicamente precedida por historial reciente de una conjuntivitis de aspecto bacteriano que no mejoró, agregando dolor profundo y fotofobia.
- - **Queratitis Herpética:** Precedida a menudo por antecedente clásico de úlceras en cara o boca. Es producida por la reactivación del **Virus Herpes Simplex 1** (HSV-1, más frecuente) pero puede ser HSV-2 o Varicela Zóster.
- - **Queratitis Sicca (Puntata):** Ulceración en fino punteado difuso, secundaria a fricción persistente por síndrome de *ojo seco* crónico. Afecta prominentemente los cuadrantes inferiores al quedar menos lubricados e insolados por el párpado.
- - **Queratitis Actínica:** Quemadura por exposición directa a luz o radiación ultravioleta. Es la clásica consulta de madrugada post-exposición de un trabajador que hizo **trabajo de soldadura sin protección ocular (máscara)**.

Diagnóstico y Manejo

- **Diagnóstico Ocular:** Se confirma 100% mediante la instilación y examen con **Tinción de Fluoresceína** bajo luz de cobalto. Descubre visualmente la de-epitelización, ulceraciones patognomónicas o abscesos. - **Tratamiento General:** Requiere profilaxis de infecciones usando **ungüentos antibióticos**, tratamiento con **lubricantes/lágrimas artificiales**, además de analgesia (**AINes** por el dolor). Es perentorio el tratamiento de la causa de base.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Queratitis Herpética y sus implicancias clínicas: Se revela en la tinción mediante un hallazgo patognomónico: **Úlcera de bordes dendríticos (con forma de rama de árbol)**. Es una condición inmensamente grave y destructora; requiere un abordaje empírico y precoz de antivirales combinados: **Aciclovir** vía tópica + Aciclovir vía oral simultáneo de manera prolongada. Si no se frena, perfora la córnea y lleva a la ceguera (indicación de trasplante de córnea a largo plazo).

2. Erosiones Corneales

Poseen un espectro de sintomatología idéntico al de las queratitis, pero se encuadran clásicamente en el recuento del paciente como producto de un antecedente directo, es decir, el trauma mecánico.

- **Causas Frecuentes:**
- - Arañazo (rama de árbol, hoja de papel).
- - Cuerpo Extraño: (impactado propiamente en el párpado superior o directamente esquirra que raspa por roce el estroma).
- - Inducida por sobreuso agresivo de **Lentes de Contacto**.

Diagnóstico y Manejo de Cuerpo Extraño/Erosión

1. Instilar fluoresceína para evidenciar la zona del rasguño corneal.
2. Si se recaba antecedente de salto de partícula retenida, realizar obligatoriamente la **maniobra de eversión del párpado superior**, pedirle al paciente que fije la vista inferomedial, y extirpar cualquier cuerpo extraño retenido usando un cotonito húmedo.
3. Tratamiento: Ungüento antibiótico empírico. Aine oral asociado por dolor intenso.

EUNACOM CRITERIOS

La Regla del Parche y Lentes de Contacto: Es posible dejar un **Parche ocular** protector estricto para alivio de erosiones o traumas en pacientes de la población general (ej: por arañazo de rama). Sin embargo, **TODO** paciente portador de erosión o queratitis inducida por el uso prolongado de **Lentes de Contacto** tiene **ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADO LA INSTALACIÓN DE UN PARCHE OCULAR**. Los lentes de contacto facilitan la inoculación de **Pseudomonas aeruginosa**. Tapar esta herida genera un ambiente húmedo y cálido perfecto para que la pseudomona licúe y abscede la córnea irreversiblemente en 24h. Obliga a derivar inmediatamente a nivel 2 o 3.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un hombre de treinta años con antecedente de espondilitis anquilosante consulta por ojo rojo izquierdo con dolor y fotofobia de dos días. Al examen hay enrojecimiento periquerático, miosis y con lámpara de hendidura se observa efecto Tyndall. No hay hipopión. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para ojo rojo profundo 2. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La uveítis anterior se presenta con enrojecimiento periquerático, dolor, fotofobia y miosis; el signo clave es el efecto Tyndall visible con lámpara de hendidura.
- Las causas más importantes de uveítis anterior son autoinmunes: espondilitis anquilosante, enfermedad inflamatoria intestinal, Behçet y artritis idiopática juvenil.
- El glaucoma agudo de ángulo cerrado es emergencia oftalmológica: dolor intenso, halos de colores, náuseas, midriasis fija y córnea turbia.
- El tratamiento médico del glaucoma agudo es timolol, pilocarpina, acetazolamida y manitol; el definitivo es iridotomía con láser.
- La endoftalmitis es infección intraocular, causa más frecuente postcirugía de catarata, tratamiento con vancomicina más ceftazidima intravítreas.
- La hipermetropía es un factor predisponente para el glaucoma agudo de ángulo cerrado por el ángulo iridocorneal más estrecho en ojos más pequeños.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OJO ROJO PROFUNDO 2)**PREGUNTA 1**

Un hombre de treinta años con antecedente de espondilitis anquilosante consulta por ojo rojo izquierdo con dolor y fotofobia de dos días. Al examen hay enrojecimiento periquerático, miosis y con lámpara de hendidura se observa efecto Tyndall. No hay hipopión. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Glaucoma agudo; tratamiento con timolol y pilocarpina
- B)** Uveítis anterior; tratamiento con corticoides tópicos y midriáticos
- C)** Queratitis bacteriana; tratamiento con antibióticos tópicos
- D)** Endoftalmitis; tratamiento con antibióticos intravítreos
- E)** Conjuntivitis viral; tratamiento sintomático

PREGUNTA 2

Una mujer hipermetrópe de cincuenta años consulta de urgencia por dolor ocular intenso derecho, visión borrosa y halos de colores alrededor de las luces desde hace dos horas. Refiere náuseas y vómitos. Al examen hay enrojecimiento periquerático, midriasis fija derecha y la córnea se ve turbia. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento inicial?

- A)** Uveítis anterior aguda; tratamiento con corticoides tópicos
- B)** Migraña con aura visual; tratamiento con analgésicos
- C)** Glaucoma agudo de ángulo cerrado; tratamiento con timolol, pilocarpina, acetazolamida y manitol
- D)** Endoftalmitis aguda; tratamiento con vancomicina intravítrea
- E)** Crisis hipertensiva con manifestaciones oculares; tratamiento con antihipertensivos

PREGUNTA 3

Un paciente operado de catarata hace tres días consulta por dolor ocular intenso, ojo rojo y pérdida visual progresiva en el ojo operado. Al examen hay enrojecimiento periquerático, hipopión y la visión ha disminuido significativamente desde la cirugía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A)** Reacción inflamatoria posquirúrgica normal; tratamiento con corticoides tópicos y observación
- B)** Endoftalmitis posquirúrgica; tratamiento con vancomicina más ceftazidima intravítreas
- C)** Glaucoma agudo posquirúrgico; tratamiento con timolol y acetazolamida
- D)** Uveítis anterior posquirúrgica; tratamiento con corticoides tópicos intensivos
- E)** Desprendimiento de retina posquirúrgico; tratamiento quirúrgico urgente

RESUMEN: OJO ROJO PROFUNDO 2

Esta clase abarca tres causas graves de ojo rojo profundo: la uveítis anterior, el glaucoma agudo de ángulo cerrado y la endoftalmitis. La uveítis anterior es la inflamación del iris y el cuerpo ciliar. Se presenta con enrojecimiento periquerático, dolor, fotofobia y miosis. El signo más importante es el efecto Tyndall, que es la presencia de células inflamatorias flotando en el humor acuoso visibles con lámpara de hendidura. Puede haber hipopión en casos graves. Las causas más importantes son autoinmunes: espondilitis anquilosante, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Behçet y artritis idiopática juvenil. El tratamiento son corticoides tópicos y midriáticos. El glaucoma agudo de ángulo cerrado es la emergencia oftalmológica más importante. Se presenta con dolor intenso, visión borrosa, halos de colores alrededor de las luces, náuseas y vómitos. Al examen hay midriasis fija, córnea turbia y presión intraocular muy elevada. El tratamiento médico inicial es timolol, pilocarpina, acetazolamida y manitol. El tratamiento definitivo es la iridotomía con láser. Un factor predisponente es la hipermetropía, porque el ojo es más pequeño y el ángulo iridocorneal más estrecho. La endoftalmitis es la inflamación intraocular infecciosa. La causa más frecuente es postoperatoria, especialmente después de cirugía de catarata. Se presenta con dolor, ojo rojo y pérdida visual rápida. El tratamiento es vancomicina más ceftazidima intravítreas.